

Introduction à la santé publique — Partie 1

Module 4 : Santé Publique — Fiche de cours n°1 (pages 1 à 15) | Fiche de synthèse visuelle 1/2

★ = notion tombée au concours (fréquence = nombre d'étoiles : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 36 notions ci-dessous sont les seules de cette partie du cours (pages 1 à 15) à avoir été marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours 2026-2027 (1 à 3 fois selon le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	Selon René Leriche (1936), la santé c'est la vie dans le silence des organes.	p.1
2	★★	Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique, mental et social.	p.2
3	★	Selon l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité.	p.2
4	★	Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, pas une finalité de la vie.	p.2
5	★	La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.	p.2
6	★	La santé positive met l'accent sur la vitalité et la qualité des défenses face aux défis journaliers.	p.2
7	★	Dans la santé positive, les stratégies larges prennent en compte une combinaison de déterminants.	p.2
8	★★	Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer.	p.2
9	★	Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.	p.3
10	★	Selon l'OMS (1952), la santé publique agit par le moyen d'une action collective concertée.	p.3
11	★	Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies.	p.3
12	★	La vaccination contre la variole a été réalisée par Edward Jenner en 1796 (principe d'inoculation).	p.4
13	★	Le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.	p.4
14	★	La loi relative à la protection de la santé publique date de 1902 (concept de santé publique).	p.4
15	★	Les missions de la santé publique suivent la règle des 5P : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision.	p.5
16	★	Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).	p.5
17	★	Contrairement à la médecine clinique, la santé publique s'intéresse à la population, à des groupes de personnes.	p.6
18	★	Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.	p.6
19	★	La fiabilité ou reproductibilité fait partie des propriétés des indicateurs de santé.	p.7
20	★	Les facteurs de risque font partie des différents types d'indicateurs de santé.	p.7
21	★	La centralisation et l'analyse des causes de décès constituent une source de données en France.	p.8
22	★	Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet.	p.8
23	★	L'Inserm est cité, avec le CépiDc, comme source de données sur les causes de décès.	p.8
24	★	La prévalence est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).	p.11
25	★★	La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.	p.11
26	★	L'incidence est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).	p.11
27	★★	L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas.	p.11
28	★	L'incidence se mesure sur une période de temps.	p.11
29	★	L'incidence informe sur la dynamique de la maladie.	p.11
30	★	La létalité est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).	p.11
31	★★★	La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.	p.11
32	★	La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).	p.11
33	★★	En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000.	p.12
34	★★	En 2022, les tumeurs (≈ 27 %) étaient la 1ère cause de mortalité chez les hommes.	p.13
35	★	En 2022, les maladies cardiovasculaires (≈ 24 %) étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.	p.13
36	★★	L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.	p.14

1 · DÉFINITIONS DE LA SANTÉ : POINTS DE VUE 1

p.1

- **Petit Robert** : bon état physiologique, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, équilibre et harmonie de la vie psychique ; applicable à la **population générale**.
- ★ **Médical (René Leriche, 1936)** : « la santé c'est la vie dans le silence des organes ».
- **Physiologique** : tel poids, telle capacité visuelle, auditive, respiratoire... = **normes** du fonctionnement physique et biologique.
- **Psychologique (Steichen)** : « correspondre à la **normalité** avec ses caractéristiques ».
- **Santé publique (Blum, Berkeley)** : capacité de l'organisme à maintenir un équilibre approprié à son âge et à ses besoins sociaux, raisonnablement indemne de profonds inconforts, insatisfactions, maladies ou incapacités ; et se comporter d'une façon qui permette la **survie de l'espèce** ainsi que l'accomplissement personnel ou le contentement de l'individu.

2 · DÉFINITIONS DE LA SANTÉ : POINTS DE VUE 2

p.1

- **Philosophique (Canguilhem, 1991, *Le normal et le pathologique*)** : « la santé a remplacé le salut » ; marge de tolérance aux infidélités du **milieu**, volant régulateur des possibilités de réactions ; « être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est un luxe biologique ».
- **Microbiologie (Dubos)** : **état physique et mental**, relativement exempt de gêne et de souffrance, permettant de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le **milieu** où le hasard ou le choix l'ont placé.
- **Sociologie (Bastide)** : l'homme sain riposte à un **monde complexe et mouvant**, invente de nouvelles normes de conduites, s'ajuste moins au monde qu'il n'est capable de le modifier.
- **Évolution (Cotton, Bruxelles, 1982)** : la vie = rythme continu d'interactions, **état d'équilibre instable** ; le bien-être est un état passager à reconquérir sans cesse.

3 · SANTÉ SELON L'OMS ET SON ÉVOLUTION

p.2

- ★★ Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien être physique, mental et social.
- ★ Selon l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou infirmité.
 - Définition de l'OMS = la plus utilisée.
- ★ Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie, pas une finalité de la vie.
- ★ La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.
- ★ La santé positive met l'accent sur la vitalité et la qualité des défenses face aux défis journaliers (défi corporel, mental et social).
 - Hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.
- ★ Dans la santé positive, les stratégies larges prennent en compte une combinaison de déterminants.
 - Empowerment = accroissement de l'efficacité individuelle et des appuis sociaux.
- ★★ Conférence d'Ottawa (1986) : la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de l'améliorer.
- Charte d'Ottawa (1986) : santé = mesure dans laquelle un individu ou un groupe peut réaliser ses aspirations, satisfaire ses besoins et évoluer avec le milieu ; **ressource de la vie quotidienne**, non le but de la vie ; **concept positif** valorisant les ressources sociales et individuelles et les capacités physiques.
- **Campagnes** : mois sans tabac (novembre) ; « 5 fruits et légumes par jour » ; courbe des repères en nutrition ; Dry January ; « Les antibiotiques c'est pas automatique ».

4 · SANTÉ PUBLIQUE SELON L'OMS (1952)

p.3

- ★ Selon l'OMS (1952), la santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus.
- ★ Selon l'OMS (1952), la santé publique agit par le moyen d'une action collective concertée.
- L'action collective concertée vise à **assainir le milieu**, lutter contre les maladies d'**importance sociale**, enseigner les règles de l'**hygiène personnelle**, et mettre en œuvre des **mesures sociales** assurant à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé.
- ★ Selon l'OMS (1952), l'action collective concertée vise à **organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies**.
- **Objet final** : permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité.

5 · HISTOIRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

p.4

- **Antiquité** : Serment d'Hippocrate = déontologie de la pratique médicale, soins gratuits à l'indigent (au plus pauvre) ; en cas d'épidémie, partir loin, vite et longtemps (action sur le groupe).
- **Moyen Âge** : hôtels-Dieu (ordres religieux pour infirmes, vieillards, orphelins...) ; **peste noire** 1347, Marseille, toute l'Europe, **30-50 % de décès**, premières mesures de santé publique.
- ★ **18e siècle** : **vaccination contre la variole par Edward Jenner (1796)**, principe d'inoculation.
- ★ **19e - début 20e siècle** : le courant hygiéniste correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.
 - Semmelweis : hygiène hospitalière et aseptie.
 - Louis Pasteur : hypothèse d'agents à l'origine des épidémies (tuberculose), pasteurisation, aseptie chirurgicale, vaccination anti-rabique (agent pathogène atténué).
- Hygiène publique en France : Comité consultatif d'hygiène publique de France (1848).
- ★ En France : loi relative à la protection de la santé publique, concept de santé publique (1902).

6 · MISSIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

p.5

- **OMS (2002)** : « ensemble des efforts par des institutions publiques dans une société » pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population, grâce à une action collective.
- ★ **Règle des 5P : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision.**
- **Protection** : enrayer la propagation de maladies (urgences sanitaires, maladies infectieuses, risques environnementaux, santé des travailleurs).
- ★ **Prévention** : éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).
- **Promotion** : encourager « les habitudes de vie saines » (comportements favorables à la santé, déterminants sociaux de la santé).
- **Prévision** : surveiller les maladies et les risques pour la santé.
- **Provision** : donner des soins pour la santé.
- **Discipline autonome** : s'occupe de l'état de santé d'une collectivité/groupe et de la **santé globale des populations**.

7 · MÉDECINE CLINIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE

p.6

- **Koop** : « Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ».
- **Médecine clinique** : traiter la **maladie** ; prend en charge une **personne** (« colloque singulier ») ; approche de soin ; méthodes **thérapeutiques** ; approche **par maladie**.
- **Santé publique** : traite de la **santé** ; **promotion** de la santé, **prévenir** l'apparition des maladies ; **épidémiologie**, administration de la santé, sociologie ; approche par **populations**, **facteurs de risque**, **déterminants**.
- ★ Contrairement à la médecine clinique, la santé publique s'intéresse à la **population**, à des **groupes de personnes**.

8 · MESURER L'ÉTAT DE SANTÉ : INDICATEURS

p.6-7

- **Raisons** : crises sanitaires (amiante 1970, hormone de croissance 1980, sang contaminé 1983, ESB 1985-1991, canicule 2003, Covid 2020) ; **mondialisation** (maladies d'importation, réémergence, émergence : SRAS, Mpx...) ; **inégalités** ; évolution temporelle préoccupante.
- ★ **Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.**
- **Définition** : instrument de mesure grâce auquel des ensembles d'informations ou de données sont **agregés, simplifiés ou résumés**.
- ★ **La fiabilité ou reproductibilité fait partie des propriétés des indicateurs de santé.**
 - Autres propriétés : disponibilité, simplicité à l'usage, exactitude (notamment précision).
- Éléments indispensables à la **connaissance de l'importance des problèmes de santé**, à la **prise de décision** et à l'**orientation de la recherche étiologique** ; outils pour les gouvernements, agences de santé publique, organisations médicales.
- **Conditions** : définir la **population** et la **période** ; choisir les indices mesurant la fréquence de l'affection étudiée, les morbidités ; calculer les indices de populations soumises au risque, traitées ou décédées. Exemple : suivi du **Sars-Cov-2** (Covid) en 2020.
- **Types** : mortalité, morbidité, handicap, démographiques (parfois ajoutés par certains auteurs).
- ★ **Les facteurs de risque font partie des différents types d'indicateurs de santé.**

9 · SOURCES DE DONNÉES EN FRANCE

p.8-9

- ★ La centralisation et l'analyse des causes de décès constituent une source de données en France.
- ★ Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France, en accès libre sur internet.
 - Causes directes et indirectes ; tri possible par âge, par sexe...
- ★ L'Inserm est cité, avec le CépiDc, comme source de données sur les causes de décès.
- Autres sources : certificat de santé ; registres des cancers ; vigilances ; système européen des accidents de la vie domestique et des loisirs ; enquêtes nationales périodiques ; données médico-administratives ; données démographiques (Insee, INED) ; MDO ; registre maladie professionnelle (IARC de Lyon, CRAM...).
- Big data : explosion quantitative des données numériques ; outils d'exploitation facilitée, haute technicité ; objet de recherche en bio-informatique (surveillance et détection des états de santé).
- Registres des cancers : 25 en France (14 généraux, 11 spécialisés) ; informations : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens.
 - Objectif : identifier tous les cas de cancer par localisation sur un territoire donné (enregistrement continu et exhaustif) ; population de référence : le département (le plus souvent).
 - Utilisation : extrapolation possible à l'ensemble du territoire (structure de population, standardisation ; létalité ; mortalité).

10 · MORBIDITÉ ET PERCEPTION DE LA SANTÉ

p.10

- Morbidité = maladies et pathologies ; 3 types : ressentie, diagnostiquée, réelle.
- Enquête Insee 2002-2003 : 48,8 % de la population se sent en bonne santé (hommes 48,5 % ; femmes 49,0 %).
 - Très bonne santé : hommes 28,2 %, femmes 21,5 % ; moyenne santé : hommes 19,5 %, femmes 24,7 % (les femmes se trouvent plus en moyenne ou mauvaise santé).
- Avec l'âge : très bonne santé en diminution, mauvaise santé en augmentation ; santé perçue de plus en plus négativement (même tendance hommes/femmes).
 - Femmes en un peu moins bonne santé que les hommes du même âge : cela explique pourquoi elles consultent plus.
- Les hommes déclarent moins souffrir d'une maladie (chronique ou non) que les femmes ; pourtant, ce sont les hommes qui sont le plus atteints.

11 · INDICATEURS DE MORBIDITÉ ET MORTALITÉ

p.11

- ★ La prévalence est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).
- ★ ★ La prévalence correspond au nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné.
 - Reflète l'importance quantitative de la maladie.
- ★ L'incidence est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).
- ★ ★ L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas.
- ★ L'incidence se mesure sur une période de temps.
- ★ L'incidence informe sur la dynamique de la maladie.
 - Épidémie ou non.
- ★ La létalité est un indicateur de morbidité (épidémiologie descriptive).
- ★ ★ ★ La létalité correspond au nombre de décès parmi les malades.
 - Informe sur la gravité de la maladie.
- Taux de reproduction, noté R : cas secondaires engendrés par un cas ; informe sur la contagiosité.
- ★ La mortalité correspond au nombre de décès (indicateurs de mortalité brute ou spécifique).

12 · MORTALITÉ EN FRANCE

p.12

- Source : CépiDc ; 600 000 à 650 000 décès par an.
 - 2020 : 653 047 ; 2022 : 670 000 (augmentation liée au Covid, grippe, canicule) ; 2023 : 639 300 (diminution de 5,3 %).
- ★ ★ En France, le nombre de décès en 2024 était de 646 000.
 - Augmentation de 6700 par rapport à 2023.
- Taux brut de mortalité = nombre de décès / population (68,4 millions) ; 9,4/1000 en 2023 et 2024.
- Taux de mortalité infantile = nombre de décès avant 1 an / nombre de naissances vivantes ; 2024 : 4,1/1000 (réanimation des prématurés de plus en plus précoces, mais plus de décès dans l'année qui suit).
- 2025 : pour la première fois, décès > naissances (inversion des courbes pas observée depuis la guerre).
- Globalement, surmortalité masculine (toutes causes, pour toutes les classes d'âge).
- Mortalité plus importante avec l'âge : à partir de 65 ans, décès considérés comme naturels et liés au vieillissement ; avant 65 ans, capacité d'accompagner les gens pour qu'ils ne meurent pas.

13 · PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITÉ

p.13

- ★ ★ En 2022, les tumeurs (≈ 27 %) étaient la 1ère cause de mortalité chez les hommes.
- ★ En 2022, les maladies cardiovasculaires (≈ 24 %) étaient la 1ère cause de mortalité chez les femmes.
- Démences 7 % ; causes externes 6 % ; appareil respiratoire 2 %.
- 1980-2004 : diminution des décès cardiovasculaires (thérapeutiques, défibrillateurs) ; très grande stabilité des décès par tumeurs/cancers.
- Inversion 2000 → 2008 : en 2000, rang 1 maladies cardiovasculaires, rang 2 tumeurs ; en 2008, rang 1 tumeurs, rang 2 maladies cardiovasculaires.

14 · ESPÉRANCE DE VIE

p.14

- ★ ★ L'espérance de vie correspond au nombre moyen probable d'années à vivre.
- Hausse continue depuis les années 1970 (quelques ralentissements récents). 2023 : hommes 80,0 ans, femmes 85,7 ans.
- Femmes toujours avantagées, écart en réduction : 7,8 ans (1997), 7,0 (2007), 5,9 (2022) ; avancée de la science médicale pour tous, facteurs de risque des femmes identiques à ceux des hommes (alcool, tabac, sédentarité).
- À 35 ans : hommes cadres 44,5 ans, hommes ouvriers 38 ans.
- À 65 ans : hausse globale (femmes et hommes) ; systématiquement plus élevée chez les femmes (écart qui tend à se réduire).
- Baisses brutales lors des grandes guerres (surtout hommes), reprise rapide ; décrochages lors d'événements socio-économiques, pandémies...
- France (2014) : femmes > hommes dans toutes les régions ; disparités régionales marquées, plus faible dans le nord et l'Outre-mer. Europe 2024 : femmes 85,8 ans (devant l'Allemagne, derrière l'Espagne) ; hommes 80,2 ans (> Allemagne, derrière l'Espagne).

15 · MORTALITÉ INFANTILE, ISF ET POPULATION

p.15

- Taux de mortalité infantile en augmentation : 3,6/1000 (2018), 4,1/1000 (2024) ; être attentif à la première année de vie, notamment chez les grands prématurés.
- ISF = nombre d'enfants par femme ; à distinguer du taux de fécondité (enfants nés vivants de l'année / population moyenne de l'année des femmes en âge de procréer) ; indicateur clé des dynamiques démographiques et des politiques familiales.
- Seuil de remplacement = 2,1 (pays développés, sans immigration) ; si ISF < seuil : possible diminution de la population à long terme sans apport migratoire.
- Population : 62,6 millions (2009) → 68,4 (2023), en augmentation même si naissances < décès en 2025.
- ISF en diminution : 2,0 (2009), 1,68 (2023, baisse depuis 9 ans), < 1,5 (2025).

Introduction à la santé publique — Partie 2

Module 4 : Santé Publique — Fiche de cours n°1 (pages 16 à 21) | Fiche de synthèse visuelle 2/2

★ = notion tombée au concours (fréquence = nombre d'étoiles : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 5 notions ci-dessous sont les seules de cette partie du cours (pages 16 à 21) à avoir été marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours 2026-2027 (1 à 3 fois selon le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1 ★	La mortalité prématurée correspond aux décès survenus avant l'âge de 65 ans.	p.18
2 ★★	La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.	p.18
3 ★	Les facteurs liés au système de santé (soins, iatrogénie) font partie des déterminants de la santé.	p.20
4 ★	Un facteur de risque est une variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie ou d'un décès.	p.21
5 ★★	Une maladie multifactorielle est due à un complexe de facteurs, chacun représentant une part de la cause (Rothman, 1976).	p.21

1 • DONNÉES DISPONIBLES SUR LA MORBIDITÉ p.16

- **Plateforme Odissé** : portail open data de Santé publique France (données, visualisations, informations par région), **en accès libre** ; indicateurs de référence issus de **70 systèmes** de surveillance, d'enquêtes et d'expertise scientifique.
 - Objectifs : suivre l'état de santé de la population et son évolution ; anticiper les risques sanitaires ; favoriser les mesures d'intervention en santé publique.
 - Thématiques : accidents et traumatismes, dépistage, environnement et santé, habitudes de vie, maladies infectieuses, maladies chroniques, périnatalité, santé au travail, santé mentale, socio-démographie.
 - Exemples : arboviroses (chikungunya, dengue, Zika) ; maladies cardiovasculaires.
- **Réseau sentinelle** : collecte continue d'informations en médecine ambulatoire chez un échantillon de **médecins généralistes et pédiatres** (France métropolitaine).
 - Surveillance épidémiologique **hebdomadaire** (infection respiratoire aiguë, diarrhée aiguë, varicelle...) ; indicateurs **actualisés chaque année** avec Santé Publique France, selon les objectifs de santé publique et les travaux de recherche en cours.

2 • INÉGALITÉS DE SANTÉ p.17

- Niveaux de différence : liées au **sexe**, aux **catégories socio-professionnelles**, **géographiques**.
- **Europe** : espérance de vie à la naissance plus élevée au **sud** (Espagne, Italie : autour de 80 ans) ; plus faible dans plusieurs pays d'**Europe de l'Est** (plus de 5 ans d'écart).
- **États-Unis** : **5 ans** de plus pour les femmes ; espérance de vie plus faible pour la population noire que blanche (**5 ans** d'écart) ; mortalité infantile nettement plus élevée pour la population noire ; raisons : **inégalités sociales et d'accès aux soins**.

3 • MORTALITÉ PRÉMATURÉE p.18

- ★ **La mortalité prématurée correspond aux décès survenus avant l'âge de 65 ans.**
- **Causes** : tumeurs (cancers) ; morts violentes (accidents de la voie publique, domestiques...) ; maladies de l'appareil circulatoire (AVC, infarctus du myocarde...).
- ★★ **La mortalité évitable est liée aux comportements à risque.**
 - Actions à mener pour éviter les décès.
- **France** : sous-mortalité prématurée dans les cantons socialement favorisés (offre de soins libérale peu élevée) ; **surmortalité** générale et prématurée dans les cantons à forte proportion d'ouvriers (peu dotés en équipements de santé) ; mortalité évitable largement plus élevée chez les **hommes** (malgré une tendance à la diminution).
- **Europe** : dans tous les pays, mortalité prématurée plus élevée chez les **hommes** ; taux plus faibles en Europe **occidentale et du Nord**, plus élevés dans plusieurs pays d'**Europe de l'Est**.

4 • ACTIONS SUR LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE p.19

- **Tumeurs** : préventions primaire et secondaire (tabac, alcool...) ; dépistage et prise en charge.
- **Morts violentes** : sécurité routière (ceintures de sécurité, airbags..., radars automatiques, sanctions) ; alcool au volant (contrôles) ; prévention du suicide.
- **Appareil circulatoire** : développement de traitements ; dépistage précoce et de suivi ; défibrillateurs automatisés externes ; habitus alimentaires.

5 • INÉGALITÉS INTERNATIONALES p.20

- **Japon** : espérance de vie d'environ **85 ans** ; vaccinée, nourrie et scolarisée ; soins maternels de qualité ; accès à d'excellents services de traitement et de réadaptation, médicaments d'une valeur moyenne de **500 \$ par an** (et bien plus si nécessaire).
- **Sierra Leone** : espérance de vie ne dépassant pas **36 ans** ; peu de chances d'être vaccinée ; déficit pondéral ; mariage à l'adolescence ; 6 enfants ou plus sans aide qualifiée, décès d'enfants peu après la naissance, risque important de mourir en couches ; médicaments à hauteur de **3 \$ par an** ; à l'âge mûr, maladies chroniques : sans traitement convenable, décès prématuré.

6 • DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ p.20

- **Endogènes** : biologie, génétique.
- **Environnementaux** : géographie, lieu de travail.
- **Mode de vie** : comportements sociaux.
- ★ **Les facteurs liés au système de santé (soins, iatrogénie) font partie des déterminants de la santé.**
- **Psycho-sociologiques** (pas de détail dans le cours).

7 • FACTEUR DE RISQUE ET CAUSALITÉ p.21

- ★ **Un facteur de risque est une variable statistiquement liée à la survenue d'un accident, d'une maladie ou d'un décès.**
- ★★ **Une maladie multifactorielle est due à un complexe de facteurs, chacun représentant une part de la cause (Rothman, 1976).**
- **Liaison statistique ≠ liaison causale** : un facteur de risque peut être associé à une maladie sans en être la cause ; explications possibles : **biais, risque alpha, association secondaire**.
 - Exemple : le café peut être associé statistiquement au cancer du poumon parce qu'il peut être lié au **tabagisme**, relation causale mise en avant.
- **Critères de causalité** : force de l'association ; relation dose-effet ; **temporalité** de l'association ; reproductibilité ; plausibilité biologique.
 - **Aucun critère seul n'est suffisant pour prouver une relation causale.**